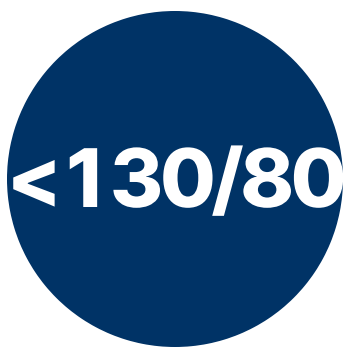


2025 AHA/ACC 고혈압 가이드라인, 목표 혈압 <130/80 mmHg 시대

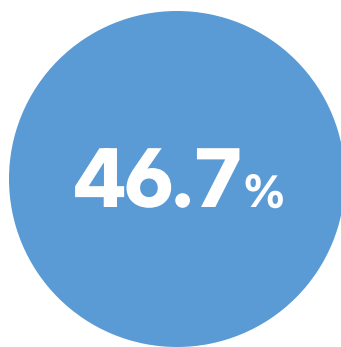
모든 성인에 일관 적용 · 130-139/80-89 mmHg 저위험군도 3-6개월 생활습관 후
약물치료 권고 — SPRINT·STEP·중국 칼륨대체염 RCT 근거

2025 가이드라인 — 무엇이 달라졌나

2017년 분류는 유지하되, 약물치료 시작 기준이 더 빨라지고 가정혈압이 더 중요해졌습니다



모든 성인 목표 혈압
(mmHg)



미국 성인
고혈압 유병률



저위험군 생활습관
후 약물치료 시작

핵심 변경 — 130-139/80-89 mmHg + 저위험군(10년 ASCVD 위험 <7.5%)이라도 생활습관 3-6개월 후 미개선 시 약물치료를 권고합니다. 가정혈압 측정·DASH 식이·저나트륨·고칼륨이 1차 치료의 핵심 축입니다. 5월 영향분석에 따르면 미국 성인 중 약물치료 대상자가 수백만 명 추가 확대될 전망입니다.

혈압 분류 4단계 — 진료 액션 매트릭스

진료실 측정 ≥ 2 회 평균 또는 가정 혈압 평균치 기준

분류	수축기	이완기	권장 액션
정상	<120	<80	매 2년 측정. 생활습관 유지.
상승 (Elevated)	120-129	<80	생활습관 강화 + 매년 평가.
1기 고혈압 (Stage 1)	130-139	80-89	생활습관 3-6개월 → 미개선 시 약물치료. 고위험군은 즉시 약물.
2기 고혈압 (Stage 2)	≥ 140	≥ 90	즉시 약물치료 + 생활습관 (2가지 약물 병용 권장).
응급 고혈압 (Crisis)	≥ 180	≥ 120	즉시 응급실. 장기 손상 평가 + 신속 강압.

가정혈압 측정 — 진료실보다 더 중요해졌습니다

새 가이드라인은 가정혈압 측정을 진단·치료 결정의 핵심 근거로 격상시켰습니다

정확한 가정혈압 측정법

- 측정 전 5분 안정 — 의자에 앉아 발 바닥에 평평히, 등 받침
- 아침·저녁 각 2회 — 1분 간격, 평균치 기록
- 커피·운동·흡연 30분 후 — 카페인·니코틴 영향 회피
- 팔 심장 높이 — 책상 위 팔 받침, 위팔 커프 사용
- 대화·휴대폰 금지 — 측정 중 침묵, 다리 꼬지 않기

※ 가정혈압 평균 $\geq 130/80$ mmHg = 진단 기준. 진료실보다 정확한 위험 예측력을 갖습니다.

진단 기준 (가정)

$\geq 130/80$ mmHg

아침·저녁 평균

측정 횟수

2회×2/일

최소 1주 평균



1차 치료 — 생활습관 6가지

Life's Essential 8 — 가장 강력한 단일 인자는 체중·식이·운동의 조합

LIFESTYLE · 01

DASH 식이

채소·과일·통곡물·저지방 유제품 위주. 수축기 8-14 mmHg 감소 효과 입증.

LIFESTYLE · 02

저나트륨 (소금)

하루 <2,300 mg → 목표 1,500 mg. 한국 평균 3,300 mg의 절반 이하 수준.

LIFESTYLE · 03

고칼륨 식이

하루 3,500-5,000 mg. 바나나·시금치·고구마·콩. 중국 SSaSS 연구 사망 감소 입증.

LIFESTYLE · 04

체중 감량

1 kg 감량당 수축기 1 mmHg 감소. 비만 환자 가장 큰 효과.

LIFESTYLE · 05

중강도 유산소

주 150분 (걷기·자전거·수영). 수축기 4-9 mmHg 감소.

LIFESTYLE · 06

절주·금연·수면

음주 남 ≤2잔·여 ≤1잔/일. 금연 시 즉시 효과. 하루 7시간 수면.

약물치료 시작 시점 — 위험도 기준

PREVENT 10년 ASCVD 위험 $\geq 7.5\%$ 가 핵심 분기점

즉시 약물치료 시작

- **2기 고혈압 ($\geq 140/90$)** — 위험도 무관 즉시 시작 (2가지 약 병용)
- **1기 + 고위험군** — ASCVD 위험 $\geq 7.5\%$, 당뇨, CKD, 65세+
- **임상적 ASCVD** — 관상동맥질환, 뇌졸중, 말초혈관질환
- **심부전·LVH** — 좌심실비대 동반 시 즉시 시작

PREVENT 10년 CVD 위험

$\geq 7.5\%$

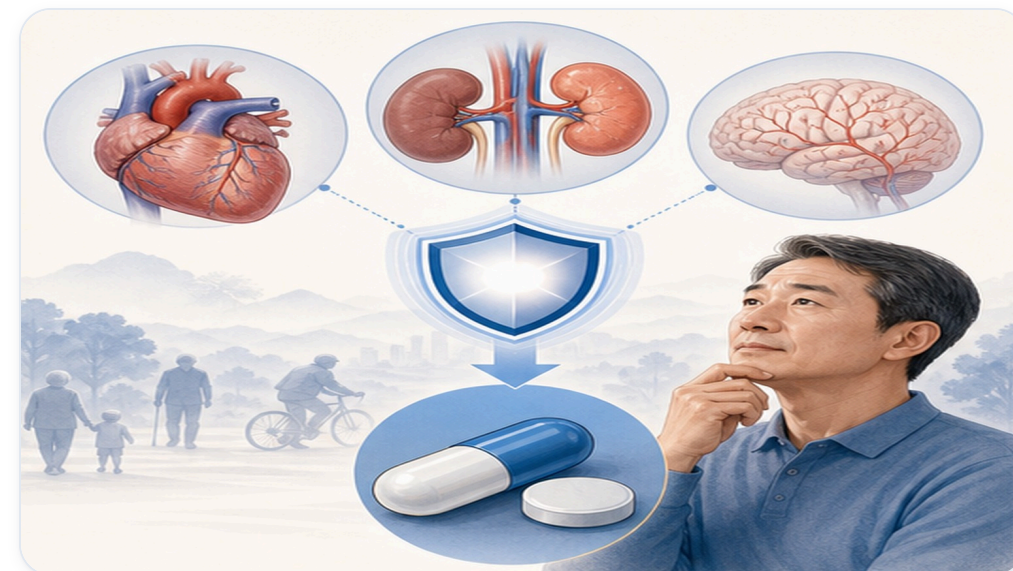
즉시 약물 기준

SPRINT 근거

-27%

엄격 강압 시 심혈관 위험

※ 1기 + 저위험군은 생활습관 3-6개월 후 재평가, 미개선 시 약물 시작.



1차 약물 4가지 계열

단일 약물보다 저용량 2가지 병용이 더 효과적·부작용 적음

DRUG · 01

ACEi / ARB

레닌-안지오텐신 차단. 당뇨·CKD·심부전 동반 시 우선. 마른기침(ACEi) 시 ARB로 전환.

DRUG · 02

CCB (칼슘차단제)

암로디핀 등. 흑인·노인 효과 우월. 발 부종·잇몸증식 주의. 흉통 동반 시 우선.

DRUG · 03

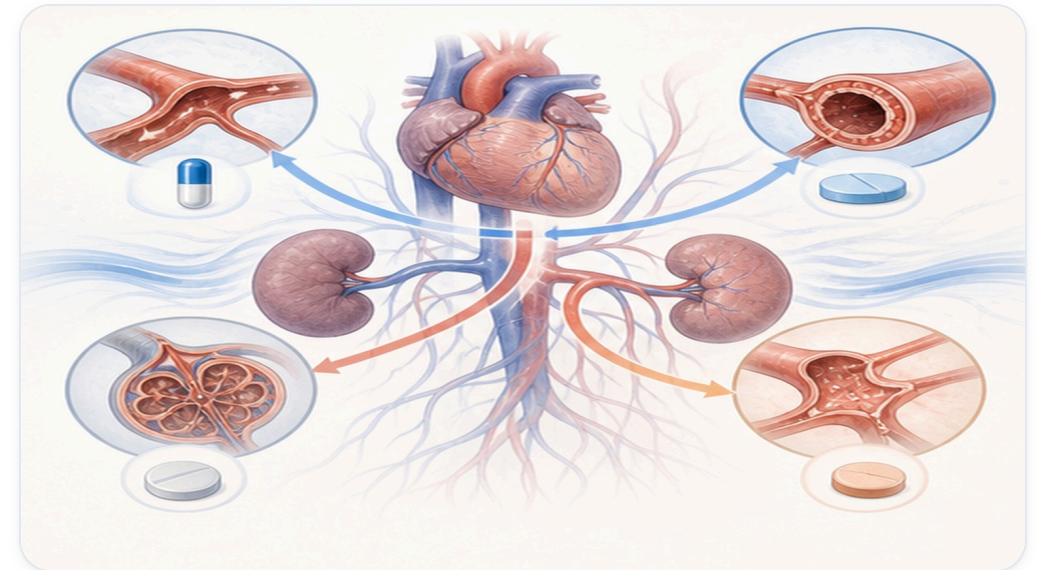
티아지드 이뇨제

클로르탈리돈·인다파미드. 저렴·효과적. K·요산 모니터. ALLHAT 1차 권장.

DRUG · 04

SPC (단일정 복합제)

ARB + CCB 또는 ARB + 이뇨제. 복용 순응도 ↑·혈압 조절률 ↑. 1차 권장.



진단·치료 흐름 4단계

고혈압 진단부터 안정 목표 도달까지의 표준 일정



즉시 응급실 — 위험 신호 6가지

아래 증상은 응급 고혈압 또는 합병증 시작 신호 — 즉시 의료기관 방문

RED FLAG · 01

갑작스런 심한 두통

평소와 다른 강도, 구토 동반. 뇌출혈·
고혈압성 뇌병증 가능성.

RED FLAG · 02

시야 흐림·복시

갑자기 한쪽 눈 시야 손상, 망막 부종
또는 망막혈관 손상 가능성.

RED FLAG · 03

흉통·호흡곤란

압박감 또는 쥐어짜는 통증, 식은땀 동반.
급성 관상동맥·심부전 의심.

RED FLAG · 04

팔·다리 한쪽 마비

말 어눌함, 안면 비대칭. 급성 뇌졸중 —
FAST 원칙, 골든타임 4.5시간.

RED FLAG · 05

코피·요혈

압력 누르지 않는 코피, 소변 색 갈색·
붉음. 표적 장기 손상 신호.

RED FLAG · 06

혈압 $\geq 180/120$

2회 측정 모두 $\geq 180/120$.
무증상이라도 즉시 진료 — 응급 고혈압.



한국 진료지침과의 간극 — 적용 시 고려

KSH 2023 vs 2025 AHA/ACC — 일반 환자 목표 차이를 함께 검토

주요 차이점

- 일반 성인 목표 — KSH 2023 <140/90 vs AHA/ACC 2025 <130/80
- 고위험군 목표 — 양쪽 모두 <130/80 (일치)
- 1기 시작 시점 — KSH 6-12개월 후 vs AHA 3-6개월 후
- 한국인 특성 — 짬 음식 섭취·신부전 동반 비율 높음

광교바른내과 접근

<130/80 고위험

당뇨·CKD·CVD 시

일반

<140/90 기본

개별 위험 따라 조정

※ 보험 급여·약물 보험 기준은 KSH 기준 적용. 임상 판단 시 환자 위험도 + 합병증을 함께 고려해 개별화합니다.

환자 실천 체크리스트 7가지

진단 직후부터 시작할 수 있는 구체적 행동

01 가정혈압 매일 아침·저녁 2회씩

5분 안정 후 1분 간격 2회 측정. 평균치 기록. 진료 시 1주 기록 지참.

02 소금 줄이기 (2,300 mg/일 이하)

국·찌개 국물 줄이기, 라면·즉석식 피하기. 영양정보 라벨 확인 습관.

03 칼륨 식품 늘리기

바나나·시금치·고구마·콩·아보카도. 신부전 환자는 제한 — 의사 확인.

04 주 150분 빠르게 걷기

하루 30분 × 5일. 식후 산책 더하면 혈압 조절·체중 모두 개선.

05 약 거르지 않기·시간 고정

매일 같은 시간 복용. 잊었을 때 12시간 이내면 바로, 이후면 다음 시간.

06 절주·금연 시작

음주 남 ≤2잔·여 ≤1잔/일. 금연은 즉시 — 시작 1년 내 효과 큼.

07 3-6개월마다 재검

혈압·신기능·전해질·소변 알부민 추적. 합병증 매년 종합 평가.

혈압 조절은 평생 함께하는 길 오늘 작은 변화 — 30년 후 더 건강한 심장

가정혈압 기록·식이·운동·약물을 함께 점검합니다 — 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요